Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90 - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51)3098-5599 - Email: frviamao2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5011987-29.2024.8.21.0039/RS

AUTOR: ALINE HAUSEN GABE PINTO

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

ALINE HAUSEN GABE PINTO ingressou com ação ordinária contra **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA,** ambos qualificados nos autos. Disse que é portadora da patologia neurológica classificada sob o CID 10 G35, Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, com prescrição médica para iniciar tratamento com OCRELIZUMABE, com a maior brevidade possível, conforme indicação do seu médico assistente. Alegou, contudo, que a operadora de saúde ré, nega-se a autorizar a dispensação do medicamento OCRELIZUMABE para que seja realizado o tratamento que necessita, ainda que haja indicação expressa em bula e não existam similares ou substitutos para o protocolo indicado. Gizou que a abordagem terapêutica prescrita, é a única alternativa compatível ao diagnóstico de EMPP que, enquanto não é tratada, segue em avanço galopante, ampliando o grau de incapacidades e dependência de terceiros. Salientou que Salienta-se que o referido medicamento é de uso restrito hospitalar, com registro na ANVISA desde 26/02/2018. Destacou que a cobertura do tratamento que lhe fora prescrito é de total responsabilidade da demandada, comentando acerca do plano de sáude contratado. Discorreu acerca da legislação aplicável à espécie. Asseverou os danos morais amargados diante da negativa da parte ré. Requereu liminarmente que fosse a ré condenada ao fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE 300MG de forma gratuita ou, a disponibilizar o valor equivalente à compra do medicamento, ou ainda, na hipótese de descumprimento de ordem judicial, seja determinado o bloqueio do valor correspondente à aquisição do medicamento junto ao mercado privado, na seguinte quantidade: *Ocrelizumabe 300mg 2 frascos Infundir 300mg, por via intravenosa, em B.I., conforme protocolo institucional, dos dias 1 e 15 do primeiro ciclo de tratamento. No dia 1 de cada ciclo subsequente (a cada 6 meses), infundir 600mg IV, em B.I., conforme protocolo institucional.* Rogou pela procedência do pedido, com a confirmação da tutela de urgência, condenando a ré à dispensação do medicamento OCRELIZUMABE 300MG à ora autora na dosagem constante no receituário médico. Pediu AJG e juntou documentos. Deu à causa o valor de R$ 210.863,00.

Deferida a gratuidade, assim como a tutela de urgência para determinar que a ré garanta a cobertura completa do medicamento OCRELIZUMABE de que necessita a autora, evento 4, DESPADEC1. Ainda, determinada a inversão do ônus da prova.

Citada, a ré contestou no evento 11, CONT2. Arguiu, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa. No mérito, aduziu a legitimidade da negativa que está embasada no fato de que o medicamento não encontra previsão no Rol de Procedimentos da ANS. Alegou ser cabível a recusa de fornecimento, nos termos da Diretriz de Utilização nº 064 da ANS. Refutou a pretensão autoral. Postulou o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência. Juntou documentos.

Irresignada com o deferimento da liminar, a ré interpôs agravo de instrumento no Ev. 13, ao qual foi dado provimento para revogar a tutela de urgência deferida à autora.

A autora replicou no evento 27, PET1.

O MP declinou da intervenção no evento 31, PROMOÇÃO1.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

De início, rejeito a impugnação ao valor da causa alegada em contestação.

De acordo com o art. 291 do CPC, *"a toda causa deverá ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível".*

No presente feito, a parte autora pretende o cumprimento de contrato de plano de saúde, consubstanciado no fornecimento de medicamento por período superior a 01 (um) ano. Neste viés, o valor da causa deverá ser fixado em consonância com a previsão contida no art. 292, II, § 2º do diploma processual, que prevê:

> *"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
>
> *II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;*
>
> *§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações".*

Posto isso, passo à análise do mérito.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, porquanto se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC.

Ademais, no caso do plano de saúde, tal entendimento encontra-se consagrado na Súmula 608 do STJ que assim disciplina:

> *"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

Veja-se que a autora é beneficiária do plano de saúde UNIMED, categoria UNIMAX inscrição nº 0 048 204087512223 0, tratando-se de cobertura ambulatorial e hospitalar, com abrangência nacional, de modo que tal contrato deve ser esquadrinhado sob as normas da Lei nº 9.656/98 e do CDC.

Incontroverso que o plano de saúde réu negou à autora o fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, administrativamente, como se vê do evento 1, CERTNEG10.

Em juízo, o demandado reforçou a negativa, ao argumento de que o medicamento não encontra previsão no Rol de Procedimentos da ANS, porquanto não consta na listagem da diretriz nº 64 da ANS, sendo a cobertura faculdade da operadora do plano de saúde, razão pela qual ela pode negá-la sem que sua conduta se configure como ato abusivo.

Na hipótese ventrada aos autos, há o diagnóstico da patologia neurológica classificada sob o CID 10 G35, Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva e a correspondente indicação do medicamento OCRELIZUMABE, no atestado médico do evento 1, LAUDO8 e evento 1, RECEIT9.

A propósito, destaco (evento 1, LAUDO8):

> **Nome:** Aline Hausen Gabe Pinto
> **CPF:** 430.354.930-49 **Data e hora:** 17/04/2024 - 17:18:30 (GMT-3)
>
> **Relatório neurológico**
>
> A Sra. Aline, 60 anos, está em acompanhamento no Ambulatório de Neuroimunologia do Hospital São Lucas da PUCRS devido a esclerose múltipla primariamente progressiva (CID-10 G35), em fase precoce (EDSS 3,5), diagnosticada em jan/24 conforme os critérios de McDonald modificados em 2017. Apresenta fraqueza e formigamentos nos 4 membros, bem como desequilíbrio, fadiga, urgência miccional, engasgos e dificuldade para achar palavras, com início insidioso em 2019 e piora progressiva desde então. A RM de crânio e coluna demonstra inúmeras lesões desmielinizantes no cérebro e na região bulbomedular. Apresenta bandas oligoclonais no líquor. Realizou ampla investigação que afastou diagnósticos alternativos.
>
> Necessita iniciar tratamento com ocrelizumabe, conforme receita anexa, com a maior brevidade possível. Trata-se da única medicação comprovadamente eficaz para a forma primariamente progressiva da esclerose múltipla (conforme ensaio clínico de fase 3 ORATORIO, em anexo) e aprovada pela ANVISA e por agências estrangeiras para esta indicação (incluindo FDA nos EUA e NICE no Reino Unido, também em anexo). Desse modo, a cobertura do ocrelizumabe para usuários de planos de saúde, como a Sra. Aline, encontra amparo na Lei 14.454 de 2022. Eventual atraso no início do ocrelizumabe associa-se a piora adicional do quadro neurológico, com acúmulo de incapacidade irreversível e piora da qualidade de vida e da capacidade funcional.

Com relação ao diagnóstico, não houve impugnação pela ré. A oposição, em realidade, se deu contra o fármaco postulado, entendendo a demandada que este não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS.

Com efeito, uma vez constatada a necessidade do medicamento em questão solicitado pelo médico que atende a autora (evento 1, LAUDO8) haja vista sua situação de saúde, sendo portadora de Esclerose Múltipla, bem como a confirmação de que o atraso no início do OCRELIZUMABE associa-se a piora adicional do quadro neurológico, com acúmulo de incapacidade irreversível e piora da qualidade de vida e da capacidade funcional, tenho que não há justificativa para a negativa apresentada.

Oportuno ressaltar que a Lei nº. 9.961/2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece no inc. III do art. 4º *que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº. 9.656/1998 e suas excepcionalidades.*

Diante da previsão legal, a ANS estabelece uma lista de tratamentos, denominada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer, os quais, atualmente, estão especificados na Resolução nº. 465/2021.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.886.929 e 1.889.704, definiu que o rol da agência reguladora é, em regra, taxativo. Contudo, após a decisão, a questão foi discutida no Congresso Nacional, culminando a aprovação e a sanção da Lei nº. 14.454/2022, cuja redação acrescentou o § 13º no art. 10 da Lei nº. 9.656/1998, sendo estabelecidos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos na lista da ANS:

> *Art. 10. [...]*
>
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

Logo, diante da inclusão do § 13º do art. 10 da Lei nº. 9.656/1998, os tratamentos indicados no rol da ANS não são taxativos, tampouco representam exclusão tácita da cobertura contratual, sendo a sua finalidade apenas estabelecer garantia de cobertura mínima a ser prestada pelas seguradoras, cabendo, contratualmente, de forma voluntária ente as partes, prever coberturas outras, além de eventuais coparticipações.

Ademais, é ilícita a cláusula contratual que disponha a respeito de exclusão do tratamento, quando presente a cobertura legal para a patologia apresentada, sendo aplicável o disposto no artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

> *Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.*
>
> *Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:*
>
> *I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; (...)*
>
> *IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)*
>
> *XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; (...)*

Outrossim, consoante prevê os arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os relativos ao tratamento de câncer e correlacionados, que são de fornecimento obrigatório.

No mesmo sentido, dispõe os arts. 17 e 18 da Resolução nº 465/2021 da ANS, que atualizou o rol de procedimentos mínimos estabelecidos para a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde:

> *"Art. 17, Resolução nº 465/2021, ANS: A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*
>
> *Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;*
>
> *(...)".*

No caso em tela, entretanto, os fármacos postulado não consistem em medicamentos de uso domiciliar, sendo aplicado de maneira intravenosa e com a necessidade de auxílio de profissional da saúde, conforme se extrai do receituário médico (evento 1, RECEIT9), de modo que não se enquadra em hipótese legal de exclusão de cobertura.

Cito, nessa linha, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

> *RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.*
>
> *1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 02/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/10/2020 e atribuído ao gabinete em 17/03/2021.*
>
> *2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento para tratamento domiciliar (Ferinject 1000 mg - carboximaltose férrica), não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prescrito para doença (anemia grave por deficiência de ferro) cuja cobertura está prevista no contrato.*
>
> *(...)*
>
> *8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do CC/2002.*
>
> *9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar.*

*10. **Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.***

11. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)(grifei)

Assim, ainda que a demandante esteja acometida por Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, o que ensejou a negativa de cobertura, tenho que há obrigatoriedade de fornecimento pela operadora do fármaco postulado, em razão da comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico (evento 1, NOTATEC19), atraindo o disposto na exceção prevista no inciso II do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

Veja-se que a própria bula do medicamento aprovada pela ANVISA, anexada ao evento 1, OUT17, indica a utilização do fármaco para pacientes com a patologia da autora, o que assegura a sua eficácia à luz de evidências científicas:

"1. INDICAÇÕES

Ocrevus® é indicado para o tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) e de pacientes com esclerose múltipla primária progressiva (EMPP)"

Portanto, o não preenchimento dos requisitos da DUT (diretriz de utilização) do medicamento não afasta o dever de cobertura.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu o TJRS:

*RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. **ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO OCRELIZUMABE (OCREVUS).** ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVA DE COBERTURA FOI ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 14.454/2022. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. **MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO.** ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50296877620228210010, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 10-10-2024)*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. **PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMÁRIA. FORNECIMENTO DE OCRELIZUMAB.** IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE SE FUNDAMENTA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. DEVER DE COBERTURA CONFIGURADO. No presente caso, **a parte autora foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Primária, necessitando de tratamento através de uso semestral do fármaco Ocrelizumab. Não se tratando o mesmo de uso domiciliar, não há como se afastar a cobertura contratual, já que a prescrição médica se deu com base em evidências científicas para o tratamento da doença que acomete a autora.** Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50049022020238210041, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-06-2024)*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. **PLANO DE SAÚDE.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA A PATOLOGIA. COBERTURA DEVIDA.** DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível, Nº 50025447020228214001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 24-04-2024)*

Dessarte, configurada a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente da autora, dada sua situação de saúde, tenho que a procedência do pedido é medida que se impõe.

ISTO POSTO, JULGO **PROCEDENTE** o pedido contido na presente ação para **conceder a liminar na sentença,** a fim de:

a) *condenar* a parte ré na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento *OCRELIZUMABE 300mg 2 frascos Infundir 300mg, por via intravenosa, em B.I., conforme protocolo institucional, dos dias 1 e 15 do primeiro ciclo de tratamento. No dia 1 de cada ciclo subsequente (a cada 6 meses), infundir 600mg IV, em B.I., conforme protocolo institucional*, nos termos da fundamentação, **no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão**, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base nos art. 536, § 1º, e 537, § 1º, ambos do CPC, e nos termos do Enunciado 86 das Jornadas de Saúde do CNJ, independentemente do trânsito em julgado, devendo a autora, semestralmente, a contar de cada aplicação, juntar relatório médico circunstanciado, nos termos do Enunciado 2 das Jornadas da Saúde do CNJ.

Sucumbente a parte ré, arcará com a integralidade das custas e honorários advocatícios devidos à parte contrária, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), forte no artigo 85, § 8º do CPC, dada a singeleza da causa e o trabalho desenvolvido.

Sentença publicada, registrada e partes intimadas, tudo eletronicamente.

Diante da nova sistemática do CPC acerca da inexistência do juízo de admissibilidade, (art. 1010, § 3º do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, §1º, do CPC.

Após o trânsito em julgado: a) sugere-se ao interessado que, após o trânsito em julgado da sentença, promova-lhe o protesto extrajudicial, conforme Ofício 047/2020-CGJ e Diretriz Estratégica 3 da Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 976 e 994, da Consolidação Normativa Notarial e Registral – CNNR; b) havendo custas pendentes, encaminhe-se ao Departamento de Receitas do TJRS, sendo o caso.

Oportunamente, baixar.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO EDEL LIGORIO FAGUNDES, Juiz de Direito**, em 04/06/2025, às 18:36:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10083931633v53** e o código CRC **fdde73b3**.